स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत सरकारी संगठन

Government and Intergovernmental Health Organizations

स्वास्थ्य संगठनों की संकल्पना

स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसी संस्थाएँ कार्य करती हैं जो नीति बनाती हैं, सेवा उपलब्ध कराती हैं, शोध करती हैं, रोगों की निगरानी रखती हैं या खाद्य तथा औषधि की गुणवत्ता का नियमन करती हैं। इनके कार्यों का समन्वय व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्वास्थ्य में योगदान देता है।

इस अध्याय में भारत की सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं के साथ **WHO** और **UNICEF** जैसे संयुक्त राष्ट्र तंत्र के संगठन शामिल हैं। **WHO** एक अंतरसरकारी विशिष्ट एजेंसी है और **UNICEF** संयुक्त राष्ट्र का कोष है; वे भारत सरकार के विभाग नहीं हैं।

अध्याय के प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	मुख्य विषय
अंतरराष्ट्रीय स्तर	**WHO**, **UNICEF** और संबंधित विकास संस्थाएँ
राष्ट्रीय स्तर	मंत्रालय, शोध, निगरानी, प्रशिक्षण तथा नियमन
राज्य और स्थानीय स्तर	प्रशासन, सेवा केंद्र और समुदाय तक पहुँच
समन्वय	कार्यक्रम, संस्थाएँ, कार्यकर्ता और सेवा की गुणवत्ता

भूमिका के अनुसार पहचान

एक शोध संस्था और एक अस्पताल दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं, लेकिन उनका मुख्य काम समान नहीं है। संस्था का नाम, अधीनता, उद्देश्य और वास्तविक कार्य साथ समझना चाहिए।

> स्वास्थ्य संगठन का अध्ययन केवल स्थापना वर्ष याद करना नहीं; यह समझना भी है कि वह स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या काम करता है।

संस्थाओं की प्रकृति का वर्गीकरण

Classification of Institutions

प्रकार	प्रमुख अर्थ	उदाहरण
सरकारी विभाग	शासन का प्रशासनिक भाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
सरकारी स्वायत्त संस्था	सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अलग कार्यात्मक व्यवस्था	**ICMR** और **NIHFW**
सांविधिक निकाय (**Statutory Body**)	कानून के आधार पर गठित संस्था	**FSSAI** और **NMC**
अंतरसरकारी संगठन	देशों की साझी संस्थागत व्यवस्था	**WHO**
संयुक्त राष्ट्र कोष या कार्यक्रम	UN तंत्र के विशिष्ट उद्देश्य वाला कोष या कार्यक्रम	**UNICEF** और **UNDP**

वर्गों का ओवरलैप

“सरकारी”, “स्वायत्त” और “सांविधिक” हमेशा एक-दूसरे के विपरीत वर्ग नहीं हैं। कोई सार्वजनिक संस्था स्वायत्त भी हो सकती है और कानून से गठित भी। उसका पूरा संस्थागत संदर्भ महत्त्वपूर्ण है।

गैर-सरकारी संगठन से अंतर

सरकार से अलग नागरिक या स्वैच्छिक संगठन स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है। सरकार के साथ साझेदारी या अनुदान मिलने से उसकी मूल पहचान अपने-आप सरकारी विभाग नहीं बनती।

कार्यक्रम और संस्था

NHM एक मिशन तथा कार्यक्रमात्मक ढाँचा है। उसे मंत्रालय, शोध संस्था या प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र का नाम न समझें।

> संस्था की पहचान उसके नाम के साथ गठन, प्रशासन और उद्देश्य से की जाती है।

स्वास्थ्य संगठनों की आवश्यकता

Why Health Organizations Are Needed

कार्यों का विभाजन

प्रमुख कार्य	स्वास्थ्य व्यवस्था में योगदान
नीति और योजना	प्राथमिकताएँ, मानक तथा संसाधन व्यवस्था
सेवा वितरण	रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और रेफरल
निगरानी (**Surveillance**)	रोग की प्रवृत्ति तथा प्रकोप की पहचान
शोध (**Research**)	कारण, जोखिम और हस्तक्षेप के प्रमाण
नियमन (**Regulation**)	गुणवत्ता, सुरक्षा और संबंधित मानकों का अनुपालन
प्रशिक्षण	कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना

एक संस्था सब कार्य नहीं करती

स्वास्थ्य मंत्रालय नीति तथा समन्वय में भूमिका निभाता है। प्रयोगशाला जाँच करती है, चिकित्सकीय केंद्र रोगी देखता है और नियामक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रित करती है। इन कार्यों का संबंध आवश्यक है।

समानता और पहुँच

दूरस्थ, कम संसाधन वाले या अधिक जोखिम वाले समूह तक सेवा पहुँचाने के लिए प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन और समुदाय की भागीदारी आवश्यक होती है। केवल भवन बना देना पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है।

जवाबदेही

लक्ष्य, सेवा की गुणवत्ता और परिणाम की समीक्षा सार्वजनिक संस्थाओं को बेहतर कार्य करने में सहायता देती है।

> समन्वय के बिना शोध, नीति और सेवा के बीच उपयोगी जानकारी का संबंध कमजोर हो सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन: परिचय

World Health Organization: An Introduction

WHO (World Health Organization)

विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट एजेंसी है। इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में योगदान देना है। यह देशों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य में दिशा और समन्वय प्रदान करता है।

पहचान	प्रमुख तथ्य
संविधान का अंगीकरण	1946
संविधान लागू और स्थापना	7 अप्रैल 1948
मुख्यालय	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
संस्थागत प्रकृति	संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अंतरसरकारी एजेंसी
विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल

व्यापक स्वास्थ्य दृष्टि

रोग नियंत्रण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पोषण, पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समानता जैसे क्षेत्र **WHO** के कार्य से जुड़े हैं।

सहयोग का स्वरूप

WHO तकनीकी मानक, मार्गदर्शन, शोध-संश्लेषण और देश को सहायता देता है। देश की अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था तथा शासन की जिम्मेदारी बनी रहती है।

> **WHO** की स्थापना 1948 और उसके संविधान का अंगीकरण 1946, दो अलग ऐतिहासिक घटनाएँ हैं।

WHO की शासन संरचना

WHO Governance

प्रमुख अंग

अंग	प्रमुख भूमिका
विश्व स्वास्थ्य सभा (**World Health Assembly**)	सदस्य देशों की भागीदारी से प्रमुख नीतिगत निर्णय तथा बजट की समीक्षा
कार्यकारी बोर्ड (**Executive Board**)	सभा के निर्णयों को आगे बढ़ाना तथा कार्य की तैयारी और समीक्षा
सचिवालय (**Secretariat**)	तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्य का संचालन

विश्व स्वास्थ्य सभा

सभा **WHO** का प्रमुख निर्णयकारी अंग है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और संगठन के कार्य से संबंधित विषयों पर विचार करते हैं। यह हर देश के दैनिक अस्पताल प्रशासन का प्रबंधक नहीं है।

कार्यकारी बोर्ड

बोर्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य 34 सदस्य होते हैं। उनके कार्यकाल तीन वर्ष के होते हैं। इसकी भूमिका नीति-निर्णय की तैयारी और सभा के निर्णयों को लागू करने में सहायता से जुड़ी है।

सचिवालय

महानिदेशक के नेतृत्व में तकनीकी और प्रशासनिक कार्यकर्ता वैश्विक, क्षेत्रीय तथा देश स्तर पर काम करते हैं। पद और संस्था की भूमिका को वर्तमान पदाधिकारी के नाम से अलग समझना उपयोगी है।

> सभा नीति-निर्णय, बोर्ड कार्य की दिशा और सचिवालय दैनिक तकनीकी संचालन में अलग भूमिकाएँ निभाते हैं।

WHO के क्षेत्रीय कार्यालय

WHO Regional Offices

छह क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ

क्षेत्र	संक्षेप	कार्यालय का नगर
अफ्रीका	AFRO	ब्राज़ाविल, कांगो गणराज्य
अमेरिका क्षेत्र	AMRO	वॉशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
दक्षिण-पूर्व एशिया	**SEARO**	नई दिल्ली, भारत
यूरोप	EURO	कोपेनहेगन, डेनमार्क
पूर्वी भूमध्यसागर	EMRO	काहिरा, मिस्र
पश्चिमी प्रशांत	WPRO	मनीला, फिलीपींस

क्षेत्रीय कार्य

क्षेत्रीय कार्यालय देशों की जरूरत, रोग-स्थिति और स्वास्थ्य प्रणाली के अनुसार तकनीकी सहयोग तथा समन्वय में योगदान देते हैं। वैश्विक मानक को स्थानीय परिस्थितियों से जोड़ने में इनकी भूमिका होती है।

भारत और SEARO

भारत दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की व्यवस्था से जुड़ा है। नई दिल्ली में **SEARO** का होना और भारत में **WHO** का देश कार्यालय होना अलग संस्थागत स्तर हैं।

मुख्यालय से अंतर

WHO का वैश्विक मुख्यालय जिनेवा में है। किसी क्षेत्रीय कार्यालय को पूरे संगठन का वैश्विक मुख्यालय नहीं कहा जाता।

> क्षेत्र का नाम भौगोलिक नक्शे की हर सीमा का सरल विकल्प नहीं है; **WHO** की क्षेत्रीय सदस्यता एक संस्थागत व्यवस्था है।

WHO के प्रमुख स्वास्थ्य कार्य

Major Functions of WHO

तकनीकी और नीतिगत योगदान

क्षेत्र	कार्य का उदाहरण
स्वास्थ्य मानक	रोग तथा सेवा संबंधी तकनीकी दिशा और शब्दावली
रोग नियंत्रण	टीकाकरण नीति और चयनित रोगों के नियंत्रण में सहायता
आपात स्थिति	जोखिम आकलन, सूचना और अंतरराष्ट्रीय समन्वय
स्वास्थ्य प्रणाली	सेवा क्षमता, प्राथमिक देखभाल और समान पहुँच
प्रमाण तथा आँकड़े	शोध का संश्लेषण और तुलनीय स्वास्थ्य जानकारी

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग

देशों के बीच यात्रा, व्यापार और साझा जोखिम के कारण स्वास्थ्य सूचना का समन्वय महत्त्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (**International Health Regulations**) संबंधी व्यवस्था और अन्य तकनीकी सहयोग इसी व्यापक कार्य से जुड़े हैं।

मार्गदर्शन और राष्ट्रीय निर्णय

तकनीकी सिफारिश, अंतरराष्ट्रीय दायित्व और देश का कानून अलग अवधारणाएँ हैं। **WHO** का हर दस्तावेज अपने-आप किसी देश का घरेलू कानून नहीं बनता।

उदाहरण

टीके के लिए वैश्विक तकनीकी दिशा, गुणवत्ता संबंधी आकलन और देश के नियामक की अनुमति अलग कार्य हैं। इनके बीच सहयोग होता है, लेकिन एक दूसरे का पूरा स्थान नहीं लेते।

> **WHO** की प्रमुख भूमिका तकनीकी दिशा, मानक और सहयोग है; राष्ट्रीय कार्यान्वयन की व्यवस्था अलग रहती है।

WHO और भारत में सहयोग

WHO Cooperation in India

देश की जरूरतों से जुड़ा कार्य

WHO भारत की स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ रोग निगरानी, टीकाकरण, स्वास्थ्य प्रणाली, आपात तैयारी तथा तकनीकी क्षमता के क्षेत्रों में सहयोग करता है। योजना राष्ट्रीय तथा स्थानीय प्राथमिकताओं से जुड़ी होती है।

भूमिका का संबंध

पक्ष	सामान्य भूमिका
भारत की स्वास्थ्य संस्थाएँ	नीति, संसाधन, नियमन और कार्यक्रम का कार्यान्वयन
WHO का तकनीकी सहयोग	मानक, विशेषज्ञ सहायता तथा प्रमाण का उपयोग
राज्य और जिला व्यवस्था	स्थानीय सेवा तथा निगरानी
समुदाय	सहभागिता, जानकारी और सेवा का उपयोग

रोग नियंत्रण का उदाहरण

पोलियो जैसे रोगों में निगरानी, टीकाकरण और प्रयोगशाला सहयोग महत्त्वपूर्ण रहे हैं। वास्तविक अभियान में राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय की भूमिका भी केंद्रीय होती है।

स्वास्थ्य प्रणाली का दृष्टिकोण

सिर्फ एक रोग खत्म करना पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता, प्रयोगशाला, आपूर्ति तथा विश्वसनीय सूचना की व्यवस्था अनेक कार्यक्रमों को मजबूत करती है।

> अंतरराष्ट्रीय सहायता देश की संस्थागत जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करती; उसका उद्देश्य क्षमता और परिणाम को मजबूत करना है।

UNICEF: परिचय और इतिहास

UNICEF: Introduction and History

वर्तमान नाम

UNICEF का वर्तमान नाम United Nations Children's Fund, अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यह बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करता है।

पहचान	प्रमुख तथ्य
स्थापना	11 दिसंबर 1946
मूल नाम	United Nations International Children's Emergency Fund
स्थायी UN व्यवस्था और संक्षिप्त नाम	1953 में United Nations Children's Fund; **UNICEF** संक्षेप बना रहा
मुख्यालय	न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
विशेष सम्मान	नोबेल शांति पुरस्कार, 1965

युद्धोत्तर सहायता से दीर्घकालीन विकास

आरंभ में युद्ध से प्रभावित बच्चों की तत्काल जरूरतें प्रमुख थीं। बाद में बच्चे के जीवित रहने, विकास और अधिकारों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर व्यापक कार्य विकसित हुआ।

संस्थागत पहचान

UNICEF संयुक्त राष्ट्र तंत्र का कोष है। निजी दान या गैर-सरकारी भागीदारों का सहयोग मिलने से वह सामान्य गैर-सरकारी संगठन नहीं बनता।

> मूल पूर्ण नाम और वर्तमान पूर्ण नाम अलग हैं; संक्षेप **UNICEF** ऐतिहासिक रूप से बना रहा है।

UNICEF के स्वास्थ्य और पोषण कार्य

UNICEF: Health and Nutrition

क्षेत्र	प्रमुख योगदान
मातृ और बाल स्वास्थ्य	सेवाओं की गुणवत्ता तथा संवेदनशील समूह तक पहुँच में सहायता
टीकाकरण	आपूर्ति, शीत शृंखला और कार्यक्रम क्षमता में सहयोग
पोषण	बाल कुपोषण की रोकथाम तथा उपयुक्त देखभाल का समर्थन
जल और स्वच्छता (**WASH**)	सुरक्षित जल, शौच व्यवस्था और स्वच्छता व्यवहार
बाल विकास	स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा संरक्षण को जोड़ना
मानवीय आपात स्थिति	प्रभावित बच्चों और परिवारों की आवश्यक सेवाओं में सहायता

जीवन-चक्र का संबंध

गर्भावस्था से शैशव, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की जरूरतें बदलती हैं। **UNICEF** का सहयोग इन्हें अलग-थलग कार्यक्रम मानने के बजाय परस्पर संबंध में देख सकता है।

केवल सामग्री देना पर्याप्त नहीं

टीका उपलब्ध हो, लेकिन सुरक्षित ताप, कार्यकर्ता या जानकारी न हो तो सेवा बाधित हो सकती है। इसलिए सामग्री, प्रशिक्षण, संचार और प्रणाली को साथ मजबूत करना आवश्यक है।

अधिकार और समान पहुँच

कम संसाधन वाले, दूरस्थ या संकटग्रस्त बच्चों की जरूरत पूरी करना कार्य का महत्त्वपूर्ण पक्ष है।

> बाल स्वास्थ्य में उपचार के साथ पोषण, पानी, शिक्षा और संरक्षण का भी संबंध है।

UNICEF का भारत में योगदान

UNICEF in India

ऐतिहासिक संबंध

UNICEF ने भारत में 1949 में कार्य शुरू किया। इसका सहयोग समय के साथ बाल स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, जल-स्वच्छता, शिक्षा तथा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विकसित हुआ।

साझेदारी का स्वरूप

क्षेत्र	सहयोग का उदाहरण
सरकार और कार्यक्रम	योजना, तकनीकी क्षमता और कार्यान्वयन को समर्थन
पोषण	परिवार तथा समुदाय में उपयुक्त व्यवहार और सेवा मजबूत करना
टीकाकरण	आपूर्ति तथा शीत शृंखला संबंधी व्यवस्था में सहयोग
WASH	विद्यालय, आँगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र की स्वच्छता
संचार	परिवारों तक सही और समझने योग्य जानकारी

परिवार तक प्रभाव

बाल स्वास्थ्य की सुविधा तभी उपयोगी है जब माता-पिता जानकारी समझें और सेवा तक पहुँच सकें। स्थानीय भाषाओं में संवाद, सामुदायिक सहयोग तथा संवेदनशील समूह की पहचान इसी प्रक्रिया के भाग हैं।

राष्ट्रीय जिम्मेदारी

UNICEF का सहयोग सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीय संस्थाओं के कार्य के साथ जुड़ता है। इसे भारत के सभी बाल स्वास्थ्य केंद्रों का प्रत्यक्ष संचालक नहीं समझना चाहिए।

> साझेदारी का उद्देश्य देश की प्रणाली मजबूत करना और बच्चों तक सेवा की गुणवत्ता तथा पहुँच बढ़ाना है।

WHO और UNICEF का अंतर

WHO and UNICEF: A Comparison

आधार	WHO	UNICEF
प्रकृति	UN की विशिष्ट अंतरसरकारी एजेंसी	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
स्थापना	1948	1946
मुख्यालय	जिनेवा	न्यूयॉर्क
मुख्य दृष्टि	सभी लोगों का स्वास्थ्य और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग	बच्चों के अधिकार, जीवित रहना और विकास
प्रमुख स्वास्थ्य योगदान	तकनीकी मानक, दिशा और निगरानी सहयोग	बाल सेवाएँ, आपूर्ति, पोषण, **WASH** और क्षमता समर्थन

सहयोग और ओवरलैप

दोनों टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य और पोषण में सहयोग कर सकते हैं। समान क्षेत्र में काम करने का अर्थ उनकी संस्थागत पहचान तथा सभी कार्य समान होना नहीं है।

उदाहरण

एक टीकाकरण कार्यक्रम में तकनीकी सिफारिश, टीका आपूर्ति, शीत शृंखला, राष्ट्रीय नियमन और स्थानीय सेवा अलग काम हैं। **WHO**, **UNICEF** और सरकारी संस्थाएँ अपने-अपने दायित्व से सहयोग कर सकती हैं।

सही वर्गीकरण

WHO और **UNICEF**, दोनों को भारत सरकार का विभाग या केवल दान पर चलने वाला निजी संगठन कहना गलत है।

> **WHO** की व्यापक स्वास्थ्य दिशा और **UNICEF** की बाल अधिकार केंद्रित भूमिका को साथ समझें।

UNFPA और प्रजनन स्वास्थ्य

UNFPA and Reproductive Health

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष

UNFPA का वर्तमान नाम **United Nations Population Fund** है। इसकी ऐतिहासिक शुरुआत 1967 के ट्रस्ट कोष से जुड़ी है और कार्य संचालन 1969 में शुरू हुआ। 1987 में वर्तमान नाम अपनाया गया, लेकिन मूल संक्षेप बना रहा।

प्रमुख कार्य

क्षेत्र	योगदान
प्रजनन स्वास्थ्य	सही जानकारी, सेवा और अधिकार आधारित दृष्टि
मातृ स्वास्थ्य	सुरक्षित गर्भावस्था तथा प्रसव संबंधी व्यवस्था का समर्थन
किशोर स्वास्थ्य	उम्र-अनुकूल जानकारी और सेवाओं की क्षमता
जनसंख्या आँकड़े	योजना के लिए जनसांख्यिकीय जानकारी
असमानता तथा हिंसा	संबंधित हानिकारक स्थितियों के नियंत्रण में सहयोग

अधिकार आधारित दृष्टिकोण

कार्य का आधार केवल जनसंख्या की संख्या घटाना नहीं है। व्यक्ति की जानकारी, स्वैच्छिक निर्णय, गरिमा और सेवाओं तक पहुँच महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत की व्यवस्था से संबंध

अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग राष्ट्रीय मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रणाली के साथ जुड़ सकता है। वास्तविक सेवाएँ निर्धारित राष्ट्रीय तथा स्थानीय संस्थाओं से पहुँचती हैं।

> जनसंख्या, स्वास्थ्य और अधिकार परस्पर जुड़े हैं; **UNFPA** को केवल एक संख्या-नियंत्रण कार्यक्रम न समझें।

FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम

FAO and the World Food Programme

भोजन तथा स्वास्थ्य का संबंध

संस्था	पहचान	स्वास्थ्य से प्रमुख संबंध
FAO	**Food and Agriculture Organization of the United Nations**; 1945	खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवस्था, पोषण और खाद्य मानक
WFP	**World Food Programme**; 1961	खाद्य सहायता, संकट में उपलब्धता तथा पोषण का समर्थन

FAO का योगदान

खाद्य उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जानकारी स्वास्थ्य के निर्धारकों से जुड़ती है। **FAO** और **WHO** के संयुक्त Codex Alimentarius कार्य में अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों की भूमिका है।

WFP का योगदान

संकटग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य सहायता, परिवहन तथा उपयुक्त पोषण सहयोग महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। खाद्य कमी, आपदा या विस्थापन में स्वास्थ्य सेवा के साथ भोजन की व्यवस्था भी आवश्यक रहती है।

मुख्यालय और संस्थागत अंतर

FAO और **WFP**, दोनों के मुख्यालय रोम में हैं। फिर भी **FAO** का व्यापक कृषि-खाद्य सहयोग और **WFP** का खाद्य सहायता केंद्रित कार्य एक जैसा नहीं है।

राष्ट्रीय मानकों से संबंध

अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक और भारत में लागू खाद्य नियम अलग स्तर हैं। राष्ट्रीय नियामक तथा सरकार के दायित्व बने रहते हैं।

> भोजन की उपलब्धता, पोषक गुणवत्ता और सुरक्षा, तीनों स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

UNDP और विश्व बैंक का योगदान

UNDP and the World Bank

स्वास्थ्य के लिए विकास सहयोग

संस्था	प्रमुख पहचान	योगदान का क्षेत्र
UNDP	**United Nations Development Programme**; स्थापना 1965	विकास, संस्थागत क्षमता और असमानता घटाने का सहयोग
विश्व बैंक (**World Bank**)	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थागत व्यवस्था; 1944 से ऐतिहासिक आधार	विकास परियोजना, वित्त, ज्ञान और प्रणाली समर्थन

UNDP का संबंध

गरीबी, सामाजिक अवसर, संस्थागत क्षमता और संकट की तैयारी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विकास कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिरता तथा समुदाय की क्षमता से जुड़ सकते हैं।

विश्व बैंक का संबंध

स्वास्थ्य व्यवस्था, पोषण, जल-स्वच्छता या मानव विकास परियोजनाओं में वित्तीय तथा ज्ञान सहयोग मिल सकता है। यह सीधे हर व्यक्ति का चिकित्सकीय उपचार करने वाली संस्था नहीं है।

योजना का महत्त्व

वित्त उपलब्ध होना सफलता का पूरा प्रमाण नहीं है। स्थानीय जरूरत, क्षमता, समान पहुँच और परिणाम की निगरानी भी आवश्यक हैं।

सहयोग की सीमा

अंतरराष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रीय नीति तथा सेवा व्यवस्था के साथ समन्वय से उपयोगी बनता है। संस्था का नाम देखकर किसी भी परियोजना की हर शर्त समान नहीं मानी जाती।

> स्वास्थ्य परिणामों के लिए वित्त, क्षमता और वास्तविक सेवा की गुणवत्ता को साथ समझना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग का कार्य-विभाजन

Roles in International Cooperation

टीकाकरण कार्यक्रम का उदाहरण

काम	सामान्य योगदान
तकनीकी दिशा	वैश्विक प्रमाण और **WHO** का सहयोग
आपूर्ति तथा प्रणाली सहायता	**UNICEF** और अन्य भागीदारों का सहयोग
राष्ट्रीय अनुमति तथा मानक	संबंधित नियामक और सरकारी संस्थाएँ
अभियान तथा नियमित सेवा	राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था
परिवार तक जानकारी	कार्यकर्ता, संस्था और समुदाय

एकीकृत योजना

किसी भागीदार का सहयोग पूरी व्यवस्था का विकल्प नहीं है। सामग्री, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, उपयुक्त ताप, अभिलेख और सही जानकारी एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

स्वामित्व और क्षमता

स्थानीय प्रणाली मजबूत हो तो सहयोग समाप्त होने के बाद भी सेवा टिक सकती है। केवल अस्थायी सामग्री बाँटने से स्थायी क्षमता नहीं बनती।

जवाबदेही

कार्य का लक्ष्य, किसकी जिम्मेदारी है और कौन-सा परिणाम मापा जाएगा, पहले से स्पष्ट होना चाहिए। इससे दोहराव और आवश्यक क्षेत्र की उपेक्षा कम होती है।

> अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का अर्थ साझा कार्य है; सभी संस्थाओं के दायित्व एक-दूसरे में विलीन नहीं हो जाते।

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था

India’s Public Health System

राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर

भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था अनेक प्रशासनिक स्तरों से जुड़ी है। केंद्र नीति, राष्ट्रीय कार्यक्रम, तकनीकी दिशा और सहयोग में भूमिका निभाता है। राज्य तथा स्थानीय व्यवस्था का सेवा वितरण और स्वास्थ्य प्रशासन में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

1	राष्ट्रीय स्तर	नीति, तकनीकी दिशा और व्यापक कार्यक्रम सहयोग।
2	राज्य स्तर	स्थानीय योजना, संसाधन और सेवा प्रशासन।
3	जिला और समुदाय	सेवा, निगरानी, रेफरल और परिवार तक पहुँच।

सेवा और अन्य सार्वजनिक कार्य

अस्पताल तथा केंद्र उपचार देते हैं। इसके साथ रोग निगरानी, पोषण, स्वच्छता, औषधि गुणवत्ता और कार्यकर्ता प्रशिक्षण भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का भाग हैं।

साझा काम

जल जनित प्रकोप में स्वास्थ्य विभाग के साथ जलापूर्ति और स्थानीय निकाय को काम करना पड़ सकता है। पोषण में स्वास्थ्य तथा महिला-बाल विकास व्यवस्था का सहयोग आवश्यक है।

एक जैसा मॉडल नहीं

स्थानीय पदनाम, प्रशासन और उपलब्ध सुविधा राज्य तथा क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकते हैं। मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रेफरल, सुलभ सेवा और उचित जवाबदेही है।

> स्वास्थ्य सेवा केंद्र किसी व्यापक प्रशासनिक तथा कार्यक्रमात्मक व्यवस्था का भाग होता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health and Family Welfare

MoHFW

Ministry of Health and Family Welfare भारत सरकार का केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसका कार्य स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय कार्यक्रम और संबंधित संस्थागत समन्वय से जुड़ा है।

प्रमुख विभाग	सामान्य कार्यक्षेत्र
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	स्वास्थ्य सेवाएँ, कार्यक्रम और परिवार कल्याण
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (**DHR**)	स्वास्थ्य शोध, क्षमता और संबंधित संस्थाओं का सहयोग

प्रशासन और तकनीकी कार्य

मंत्रालय नीति तथा प्रशासनिक दिशा प्रदान करता है। उसके अधीन विभाग, संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त संस्थाएँ और सांविधिक निकाय अलग जिम्मेदारियाँ निभाते हैं।

कार्यक्रम का संबंध

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अनेक रोग तथा सेवा कार्यक्रम मंत्रालय की व्यवस्था से जुड़े हैं। राज्य और जिला स्तर पर उनके कार्यान्वयन में अलग प्रशासनिक तथा तकनीकी इकाइयाँ होती हैं।

संस्थागत पहचान

ICMR का शोध संबंधी कार्य और **DGHS** की तकनीकी सलाह एक ही कार्य नहीं हैं। मंत्रालय से जुड़ाव होने के बाद भी उनकी मुख्य भूमिका अलग रहती है।

> मंत्रालय, विभाग और उसके अधीन संस्था को एक ही स्तर का संगठन न समझें।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

Directorate General of Health Services

DGHS (Directorate General of Health Services)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय **MoHFW** से संबद्ध तकनीकी संगठन है। यह चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित विषयों में तकनीकी सलाह तथा समन्वय प्रदान करता है।

प्रमुख भूमिका

क्षेत्र	योगदान
तकनीकी सलाह	सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विषयों पर मंत्रालय को विशेषज्ञ सहयोग
कार्यक्रम समन्वय	संबंधित रोग और सेवा कार्यों में तकनीकी व्यवस्था
संस्थागत संबंध	अधीन तथा संबद्ध तकनीकी इकाइयों के साथ काम
क्षमता	प्रशिक्षण, तकनीकी दिशा और आवश्यक प्रणाली समर्थन

नीति और विशेषज्ञता

स्वास्थ्य निर्णय में प्रशासनिक उद्देश्य के साथ वैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय जानकारी आवश्यक है। **DGHS** जैसी तकनीकी व्यवस्था इस संबंध को मजबूत करती है।

संस्थाओं से संबंध

NCDC तथा **CDSCO** जैसे संगठनों की अपनी विशिष्ट भूमिकाएँ हैं। उन्हें केवल एक नाम से पूरे तकनीकी तंत्र का पर्याय नहीं माना जाता।

उदाहरण

किसी रोग की राष्ट्रीय नियंत्रण रणनीति में निगरानी, सेवा, प्रयोगशाला तथा तकनीकी सलाह का समन्वय करना आवश्यक हो सकता है।

> **DGHS** की भूमिका विशेषज्ञ तकनीकी दिशा से जुड़ी है; वह हर स्थानीय अस्पताल का दैनिक संचालक नहीं है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

Indian Council of Medical Research

ICMR (Indian Council of Medical Research)

ICMR भारत में जैव-चिकित्सीय शोध की योजना, समन्वय और प्रोत्साहन का प्रमुख सार्वजनिक निकाय है। यह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, **MoHFW**, की व्यवस्था से जुड़ा है।

पहचान	प्रमुख तथ्य
ऐतिहासिक शुरुआत	1911 में **Indian Research Fund Association**
वर्तमान नाम	1949 में **ICMR** नाम अपनाया गया
मुख्यालय	नई दिल्ली
मुख्य उद्देश्य	जैव-चिकित्सीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध का समर्थन

कार्य के प्रमुख क्षेत्र

रोगों के कारण, निदान, जोखिम, पोषण, जनस्वास्थ्य और स्वास्थ्य हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन शोध में शामिल हो सकता है। परिषद अपने संस्थानों तथा अन्य शोध व्यवस्था को सहयोग देती है।

शोध से नीति तक

प्रमाण के आधार पर पोषण या रोग नियंत्रण संबंधी दिशा बन सकती है। फिर भी शोध निष्कर्ष, नियामक अनुमति और स्थानीय सेवा, अलग चरण हैं।

गुणवत्ता और नैतिकता

उचित अध्ययन विधि, प्रतिभागी की सुरक्षा, नैतिक समीक्षा और परिणाम की सही व्याख्या महत्त्वपूर्ण हैं। केवल संस्था का नाम देखकर हर दावे की स्वतः पुष्टि नहीं होती।

> **ICMR** का मुख्य केंद्र शोध है; इसे औषधियों का राष्ट्रीय लाइसेंस देने वाला निकाय न समझें।

ICMR-राष्ट्रीय पोषण संस्थान

ICMR-National Institute of Nutrition

NIN (National Institute of Nutrition)

ICMR-NIN हैदराबाद स्थित पोषण शोध संस्थान है। इसकी ऐतिहासिक शुरुआत 1918 में कूनूर के बेरी-बेरी जाँच इकाई से हुई और यह 1958 में हैदराबाद स्थानांतरित हुआ।

प्रमुख कार्य

क्षेत्र	योगदान
पोषक आवश्यकता	उम्र तथा जीवन-अवस्था के अनुसार वैज्ञानिक मानों का अध्ययन
आहार और स्वास्थ्य	भोजन, पोषण स्थिति तथा रोग जोखिम का शोध
खाद्य संघटन	खाद्य पदार्थों के पोषक घटकों की जानकारी
जनपोषण	समुदाय की स्थिति तथा हस्तक्षेप का आकलन
दिशा और प्रशिक्षण	वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग तथा क्षमता विकास

पोषक मान और आहार मार्गदर्शिका

RDA तथा अन्य पोषक संदर्भ मान पोषक तत्वों की मात्रा समझने में उपयोगी हैं। आहार मार्गदर्शिका (**Dietary Guidelines**) भोजन चयन तथा व्यवहार को व्यापक रूप में समझाती है। दोनों का उद्देश्य जुड़ा है, लेकिन स्वरूप समान नहीं है।

परिवार तक उपयोग

विविध भोजन, सही मात्रा और जीवन-अवस्था की जरूरत को वैज्ञानिक आधार से समझने में पोषण शोध योगदान देता है। विशेष रोग का आहार व्यक्तिगत चिकित्सकीय आकलन भी चाहता है।

> **NIN** पोषण शोध संस्था है; खाद्य लाइसेंस और कानूनी गुणवत्ता नियमन **FSSAI** की अलग भूमिका है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र

National Centre for Disease Control

NCDC (National Centre for Disease Control)

NCDC नई दिल्ली स्थित प्रमुख तकनीकी संस्था है, जो रोग निगरानी, प्रकोप जाँच, प्रयोगशाला सहयोग और क्षमता विकास में भूमिका निभाती है। यह **DGHS**, **MoHFW**, की व्यवस्था से जुड़ी है।

ऐतिहासिक पहचान

1963 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, अर्थात NICD, की व्यवस्था विकसित हुई। 2009 में इसका नाम **National Centre for Disease Control** रखा गया। ऐतिहासिक आरंभ इससे पहले के मलेरिया संस्थागत कार्य से जुड़ा था।

कार्य	प्रमुख उद्देश्य
रोग निगरानी	असामान्य वृद्धि तथा रोग की प्रवृत्ति पहचानना
प्रकोप जाँच	स्रोत, संपर्क और नियंत्रण की जरूरत समझना
प्रयोगशाला सहयोग	आवश्यक रोगजनक तथा नमूना आकलन
प्रशिक्षण	राज्य और जिला क्षमता मजबूत करना
तकनीकी दिशा	रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेषज्ञ सहायता

उदाहरण

जल जनित रोगों के बढ़ते मामलों में क्षेत्रीय जाँच, नमूने, रोग विवरण और जल-स्वच्छता व्यवस्था का समन्वय आवश्यक हो सकता है। **NCDC** का तकनीकी सहयोग स्थानीय जिम्मेदारियों के साथ जुड़ता है।

> रोग नियंत्रण में केवल रोगी का उपचार नहीं; निगरानी और प्रसार का कारण समझना भी आवश्यक है।

IDSP और रोग निगरानी

IDSP and Disease Surveillance

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

IDSP का पूरा नाम **Integrated Disease Surveillance Programme** है। इसकी शुरुआत नवंबर 2004 में हुई। उद्देश्य रोग संबंधी जानकारी के आधार पर असामान्य स्थिति और प्रकोप को समय पर पहचानकर प्रतिक्रिया की क्षमता मजबूत करना है।

निगरानी का चक्र

1	**जानकारी जुटाना**	स्वास्थ्य सेवा तथा प्रयोगशाला से उपयुक्त आँकड़े।
2	**विश्लेषण करना**	प्रवृत्ति और असामान्य वृद्धि की पहचान।
3	**कार्रवाई करना**	जाँच, उपचार और नियंत्रण का समन्वय।
4	**परिणाम देखना**	प्रतिक्रिया, निगरानी और आवश्यक सुधार।

तकनीकी व्यवस्था

स्वास्थ्य सेवा तथा प्रयोगशाला से मिली जानकारी जिला, राज्य और राष्ट्रीय व्यवस्था में उपयोगी होती है। **IHIP**, अर्थात **Integrated Health Information Platform**, डिजिटल सूचना तथा निगरानी से संबंधित मंच है।

आँकड़ा और कार्रवाई

केवल रिपोर्ट भेजना पर्याप्त नहीं है। गुणवत्ता, समयबद्धता, विश्लेषण और आवश्यक कार्रवाई निगरानी को उपयोगी बनाते हैं। बढ़ते मामलों की जानकारी नियंत्रण की योजना से जुड़नी चाहिए।

संस्था और कार्यक्रम का अंतर

NCDC एक संस्था है; **IDSP** एक कार्यक्रम है। **IHIP** एक सूचना मंच है। तीनों संबंध रखते हैं, लेकिन एक ही नाम या प्रकार नहीं हैं।

> निगरानी तभी सफल है जब जानकारी उचित समय पर निर्णय और कार्रवाई तक पहुँचे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

National Institute of Health and Family Welfare

NIHFW

National Institute of Health and Family Welfare नई दिल्ली स्थित स्वायत्त संस्था है। इसका गठन 9 मार्च 1977 को **NIHAE** और **NIFP** के विलय से हुआ। यह **MoHFW** की व्यवस्था में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग देता है।

मूल संस्था	पूरा नाम
NIHAE	National Institute of Health Administration and Education
NIFP	National Institute of Family Planning

प्रमुख कार्य

स्वास्थ्य प्रबंधन, परिवार कल्याण, प्रशिक्षण, शोध और कार्यक्रम मूल्यांकन इसकी भूमिकाओं से जुड़े हैं। कार्यकर्ताओं तथा प्रशासकों की क्षमता बढ़ाना सेवा की गुणवत्ता में योगदान देता है।

प्रशिक्षण का प्रभाव

सही योजना, संचार, पर्यवेक्षण और अभिलेख उपयोग के लिए कौशल आवश्यक हैं। केवल औषधि या उपकरण उपलब्ध होने से हर सेवा सही ढंग से नहीं चलती।

तुलना

ICMR का मुख्य क्षेत्र जैव-चिकित्सीय शोध है। **NIHFW** का प्रमुख योगदान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में प्रशिक्षण तथा तकनीकी क्षमता है। दोनों शोध कर सकते हैं, लेकिन मुख्य संस्थागत केंद्र अलग हैं।

> **NIHFW** और परिवार नियोजन का एक स्थानीय सेवा केंद्र एक ही स्तर की संस्था नहीं हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

Food Safety and Standards Authority of India

FSSAI

Food Safety and Standards Authority of India खाद्य सुरक्षा तथा मानकों का प्रमुख सांविधिक निकाय है। इसका विधिक आधार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 है। प्राधिकरण की स्थापना 2008 में हुई।

पहचान	प्रमुख तथ्य
प्रशासनिक मंत्रालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मुख्यालय	नई दिल्ली
मुख्य कार्य	खाद्य मानक, सुरक्षा और नियामक व्यवस्था
राज्य संबंध	संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्य

प्रमुख भूमिका

खाद्य मानक, जोखिम संबंधी जानकारी, प्रयोगशाला व्यवस्था, लाइसेंस या पंजीकरण तथा नियमों के अनुपालन में प्राधिकरण और संबंधित प्रशासन की भूमिका होती है। वास्तविक अधिकार तथा प्रक्रिया लागू नियमों के अनुसार होते हैं।

पोषण और नियमन में अंतर

NIN आहार तथा पोषण का शोध करता है। **FSSAI** खाद्य सुरक्षा और नियमन से जुड़ा है। स्वस्थ आहार संबंधी सहयोग होने पर भी दोनों को समान संस्था नहीं माना जाता।

परिवार का संबंध

खाद्य लेबल, सुरक्षित चयन और अनियमितता की सूचना जैसे व्यवहार में सही जानकारी उपयोगी है।

> **FSSAI** का प्रशासनिक मंत्रालय **MoHFW** है; इसे केवल खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का विभाग न समझें।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

Central Drugs Standard Control Organisation

CDSCO

Central Drugs Standard Control Organisation भारत का राष्ट्रीय औषधि नियामक संगठन है। यह **DGHS**, **MoHFW**, की व्यवस्था से जुड़ा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्रमुख कार्य

क्षेत्र	भूमिका का उदाहरण
नई औषधियाँ	लागू प्रक्रिया के अनुसार अनुमति और नियामक समीक्षा
चिकित्सकीय परीक्षण	निर्धारित नियामक व्यवस्था
औषधि मानक	गुणवत्ता संबंधी दिशा और संबंधित नियंत्रण
आयात	आयातित औषधियों की गुणवत्ता संबंधी भूमिका
केंद्रीय-राज्य समन्वय	नियामक कार्यों में सहयोग

साझा नियमन

केंद्र और राज्यों के औषधि नियंत्रण कार्यों का विभाजन होता है। औषधियों के निर्माण, बिक्री तथा वितरण के सभी काम केवल एक केंद्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किए जाते।

DCGI का संदर्भ

Drugs Controller General of India, अर्थात **DCGI**, केंद्रीय औषधि नियामक व्यवस्था का प्रमुख पद है। पद और **CDSCO** संस्था का संबंध समझना चाहिए।

शोध से अंतर

ICMR का अध्ययन उपयोगी प्रमाण दे सकता है, लेकिन बाजार में औषधि के लिए आवश्यक नियामक अनुमति अलग प्रक्रिया है।

> शोध, चिकित्सकीय उपयोग और नियामक अनुमति अलग चरण हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

National Medical Commission

NMC (National Medical Commission)

NMC आधुनिक चिकित्सा शिक्षा तथा संबंधित पेशेवर मानकों के लिए प्रमुख सांविधिक व्यवस्था है। इसका विधिक आधार **National Medical Commission** Act, 2019 है। यह पूर्व Medical Council of India की व्यवस्था के बाद विकसित हुआ।

चार प्रमुख स्वायत्त बोर्ड

बोर्ड	प्रमुख कार्यक्षेत्र
UGMEB	स्नातक चिकित्सा शिक्षा के मानक
PGMEB	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानक
MARB	चिकित्सा संस्थानों का आकलन और रेटिंग
EMRB	नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण

गुणवत्ता का संबंध

चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षित पेशेवर और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता परस्पर जुड़े हैं। उचित मानक तथा निगरानी भविष्य की सेवा क्षमता को प्रभावित करते हैं।

भूमिका की सीमा

NMC को खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, औषधि बाजार अनुमति संस्था या हर अस्पताल का प्रत्यक्ष संचालक नहीं समझें। अलग पेशों और चिकित्सा प्रणालियों की नियामक व्यवस्थाएँ भी अलग हो सकती हैं।

संस्थाओं का अंतर

CDSCO औषधि नियमन से और **NMC** चिकित्सा शिक्षा तथा संबंधित पेशेवर व्यवस्था से जुड़ा है। नाम में “चिकित्सा” होने से सभी कार्य समान नहीं हो जाते।

> स्वास्थ्य गुणवत्ता में संस्थागत मानक, पेशेवर कौशल और सेवा व्यवस्था साथ आवश्यक हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

National Health Authority

NHA (National Health Authority)

National Health Agency का पुनर्गठन 2019 में **National Health Authority** के रूप में हुआ। **NHA MoHFW** से संबद्ध व्यवस्था है और PM-JAY तथा डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख कार्यों से जुड़ा है।

क्षेत्र	प्रमुख उद्देश्य
PM-JAY	पात्र व्यक्तियों के लिए संबंधित अस्पताल सेवाओं की वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था
ABDM	डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र और सूचना के उपयोग का आधार
कार्यान्वयन	संबंधित राज्य तथा अन्य भागीदारों के साथ समन्वय

PM-JAY और ABDM का अंतर

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य सेवा से जुड़े खर्च की सुरक्षा पर केंद्रित है। **Ayushman Bharat Digital Mission** डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित है। दोनों को एक ही लाभ या एक ही कार्ड का नाम नहीं समझें।

ABHA

Ayushman Bharat Health Account डिजिटल स्वास्थ्य पहचान का भाग है। **ABHA** होना अपने-आप PM-JAY की पात्रता या सभी उपचार के भुगतान की पुष्टि नहीं है।

व्यवस्था और सीमा

पात्रता, अस्पताल, सुविधा और डिजिटल सूचना के उपयोग की प्रक्रिया संबंधित वर्तमान निर्देशों से तय होती है। उचित सहमति, सुरक्षा और लोगों की पहुँच महत्त्वपूर्ण हैं।

> **NHA** का स्वास्थ्य वित्त और डिजिटल व्यवस्था से जुड़ा कार्य, **ICMR** के शोध तथा **CDSCO** के नियमन से अलग है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

National Health Mission

NHM (National Health Mission)

NHM स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने और सुलभ, समान तथा गुणवत्तापूर्ण सेवा में योगदान देने वाला मिशन है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य के उप-मिशन शामिल हैं।

भाग	मुख्य संदर्भ
NRHM	**National Rural Health Mission**; 2005 से ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली का विकास
NUHM	**National Urban Health Mission**; 2013 में शहरी जरूरतों के लिए स्वीकृत उप-मिशन
NHM	दोनों उप-मिशनों को जोड़ने वाला व्यापक ढाँचा

प्रमुख कार्यक्षेत्र

मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य केंद्र क्षमता, मानव संसाधन, रोग कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ाव मिशन के व्यापक कार्यों से संबंधित हैं।

राज्य और स्थानीय योजना

राष्ट्रीय दिशा के साथ राज्य की जरूरत, जिला योजना और स्थानीय क्रियान्वयन का महत्त्व है। दूरस्थ तथा संवेदनशील समूह तक सेवा पहुँचाना प्रणाली सुधार का आवश्यक पक्ष है।

संस्था से अंतर

NHM एक मिशन है। उसका प्रत्येक कार्यक्रम, कार्यालय या केंद्र अलग प्रशासनिक व्यवस्था से चल सकता है। **NHM**, **NHA** और **MoHFW** समान संक्षेप या समान संस्था नहीं हैं।

> स्वास्थ्य मिशन की सफलता सेवा की उपलब्धता के साथ उपयोग, गुणवत्ता और समान पहुँच से आँकी जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र

National Health Systems Resource Centre

NHSRC

National Health Systems Resource Centre की स्थापना 2007 में हुई। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ तकनीकी सहयोग, नीति और रणनीति, राज्य क्षमता तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार में योगदान देता है।

प्रमुख भूमिका

क्षेत्र	कार्य का उदाहरण
प्रणाली योजना	जरूरत और संसाधन के अनुसार सेवा व्यवस्था
गुणवत्ता	स्वास्थ्य केंद्र तथा सेवा सुधार के लिए तकनीकी सहयोग
मानव संसाधन	कार्यकर्ता क्षमता और संगठन संबंधी सहायता
राज्य सहयोग	तकनीकी जानकारी तथा योजना समर्थन
मूल्यांकन	सेवा और प्रणाली के परिणाम समझने में सहायता

प्रशिक्षण से संबंध

नीति का व्यवहार में उपयोग करने के लिए कार्यकर्ता, प्रक्रिया और संसाधन की व्यवस्था आवश्यक है। तकनीकी संसाधन संस्था स्थानीय क्षमता मजबूत कर सकती है।

NIHFW से तुलना

NIHFW का प्रमुख केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में प्रशिक्षण तथा संबंधित तकनीकी कार्य है। **NHSRC** का केंद्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार तथा **NHM** से जुड़ा तकनीकी समर्थन है। कुछ कार्यों में सहयोग संभव है।

> तकनीकी सहायता संस्था सीधे सभी रोगियों का उपचार करने वाला अस्पताल नहीं है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय

State Health Departments and Local Bodies

राज्य स्तर की भूमिका

राज्य स्वास्थ्य विभाग सेवा वितरण, मानव संसाधन, कार्यक्रम कार्यान्वयन और स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाता है। राज्य की जरूरत तथा उपलब्ध संसाधन के अनुसार योजना बनाई जाती है।

स्तर या व्यवस्था	सामान्य योगदान
राज्य स्वास्थ्य विभाग	नीति का स्थानीय उपयोग, बजट और सेवा प्रशासन
राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	मिशन तथा संबंधित कार्यक्रम व्यवस्था
जिला स्वास्थ्य प्रशासन	क्षेत्र की जरूरत, निगरानी और कार्यक्रम समन्वय
स्थानीय निकाय	जल निकासी, कचरा, स्वच्छता और संबंधित सार्वजनिक सेवाएँ

राज्य के अनुसार अंतर

पदनाम और प्रशासनिक ढाँचा सभी राज्यों में बिल्कुल समान नहीं होते। मुख्य बात कार्य की स्पष्ट जिम्मेदारी और केंद्रों के बीच उचित समन्वय है।

अंतरविभागीय सहयोग

जल जनित प्रकोप में स्वास्थ्य विभाग उपचार और निगरानी करता है। जलापूर्ति तथा स्थानीय निकाय दूषण, वितरण और स्वच्छता सुधार में भूमिका निभाते हैं।

> स्वास्थ्य परिणाम केवल स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर नहीं; अनेक सार्वजनिक सेवाओं का प्रभाव पड़ता है।

सेवा केंद्र और रेफरल व्यवस्था

Health Facilities and Referral

अलग स्तर की सुविधा

केंद्र या स्तर	सामान्य भूमिका
उप-स्वास्थ्य केंद्र	समुदाय के निकट मूल स्वास्थ्य सेवाएँ
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)	प्राथमिक चिकित्सा, रोकथाम और आवश्यक रेफरल
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)	अधिक क्षमता तथा क्षेत्रीय रेफरल समर्थन
जिला अस्पताल	विस्तृत जाँच, उपचार और उच्चतर रेफरल
उच्चतर संस्थान	विशेष तथा जटिल देखभाल

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

Ayushman Arogya Mandir व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था से जुड़ा है। इसमें उप-स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक केंद्र की क्षमता मजबूत करने का संदर्भ महत्त्वपूर्ण है।

रेफरल (Referral)

रोगी की जरूरत स्थानीय क्षमता से अधिक हो तो उचित केंद्र तक भेजना रेफरल है। कारण, जानकारी, सुरक्षित परिवहन और अनुवर्ती सहायता महत्त्वपूर्ण हैं। हर केंद्र में हर विशेष सेवा उपलब्ध होने की अपेक्षा नहीं की जाती।

सेवा की निरंतरता

ऊपर के केंद्र से मिली जानकारी स्थानीय देखभाल तक लौटे तो आगे की सहायता बेहतर हो सकती है।

> संस्था का स्तर उसकी भूमिका समझाता है; वास्तविक उपलब्ध सेवा स्थानीय क्षमता तथा व्यवस्था से जाँची जाती है।

समुदाय तक पहुँचने वाले कार्यकर्ता

Community-level Health Workers

भूमिका और सहयोग

कार्यकर्ता	पूरा नाम या पहचान	प्रमुख योगदान
ASHA	**Accredited Social Health Activist**	समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच संपर्क
ANM	**Auxiliary Nurse Midwife**	मातृ-बाल स्वास्थ्य और निर्धारित स्वास्थ्य सेवाएँ
आँगनवाड़ी कार्यकर्ता	**Anganwadi Worker**	पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल तथा समुदाय से जुड़ाव

पूरक कार्य

परिवार को स्वास्थ्य जानकारी देना, उचित सेवा से जोड़ना और पोषण तथा देखभाल की जरूरत पहचानना अलग कार्यकर्ताओं के सहयोग से हो सकता है। प्रशिक्षण और वास्तविक कार्यक्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारी तय होती है।

संस्था और व्यक्ति का अंतर

ASHA कोई अलग अंतरराष्ट्रीय संस्था या निजी अस्पताल नहीं है। वह समुदाय आधारित कार्यकर्ता की भूमिका है। **ANM** और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण तथा सेवा कार्य अलग होते हैं।

समन्वय का उदाहरण

गर्भवती व्यक्ति या छोटे बच्चे की जरूरत में पोषण जानकारी, स्वास्थ्य जाँच और सेवा तक पहुँच, अलग काम हैं। कार्यकर्ता इन्हें उपयुक्त व्यवस्था से जोड़ सकते हैं।

> कार्यकर्ता की भूमिका, योग्यता और सेवा शर्तों को समान मानना उचित नहीं है।

महिला एवं बाल विकास की भूमिका

Women and Child Development

स्वास्थ्य से जुड़ा पोषण और विकास

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (**Ministry of Women and Child Development**) की व्यवस्था बाल पोषण, प्रारंभिक देखभाल, विकास और संरक्षण से जुड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इसका सहयोग मातृ तथा बाल कल्याण में महत्त्वपूर्ण है।

मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0

कार्यक्रम पोषण सहायता, प्रारंभिक बाल देखभाल तथा संबंधित व्यवस्था को जोड़ता है। बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और निर्धारित समूहों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है।

क्षेत्र	सामान्य भूमिका
पूरक पोषण	संबंधित समूह की पोषण सहायता
बाल देखभाल और शिक्षा	उम्र-अनुकूल प्रारंभिक विकास
पोषण जानकारी	परिवार तथा समुदाय का उपयुक्त व्यवहार
स्वास्थ्य से जुड़ाव	संबंधित जाँच तथा रेफरल के लिए सहयोग

आँगनवाड़ी और चिकित्सकीय सेवा

आँगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यक्रम की भागीदार हो सकती है, लेकिन उसे हर बीमारी का निदान और उपचार करने वाला अस्पताल नहीं माना जाता। जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवा से रेफरल होता है।

> पोषण, स्वास्थ्य और बाल विकास अलग विभागों से जुड़े होकर भी संयुक्त परिणाम देते हैं।

आयुष मंत्रालय

Ministry of Ayush

Ministry of Ayush

भारत में पूर्ण मंत्रालय के रूप में आयुष व्यवस्था का गठन 9 नवंबर 2014 में हुआ। यह संबंधित चिकित्सा प्रणालियों की नीति, शिक्षा, शोध, गुणवत्ता तथा संस्थागत विकास से जुड़ा है।

संबंधित प्रणालियाँ

क्षेत्र	उदाहरण
आयुर्वेद	**Ayurveda**
योग और प्राकृतिक चिकित्सा	**Yoga and Naturopathy**
यूनानी	**Unani**
सिद्ध और सोवा-रिग्पा	**Siddha and Sowa-Rigpa**
होम्योपैथी	**Homoeopathy**

शोध और गुणवत्ता

सेवा का मूल्यांकन, प्रशिक्षित व्यक्ति, औषधि की गुणवत्ता और सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हैं। किसी प्रणाली में उपयोग होने से हर उत्पाद या हर रोग संबंधी दावा अपने-आप प्रमाणित नहीं हो जाता।

अन्य मंत्रालय से अंतर

आयुष मंत्रालय और **MoHFW** अलग मंत्रालय हैं। स्वास्थ्य तथा संबंधित कार्यक्रमों में सहयोग हो सकता है, लेकिन उनकी संस्थागत पहचान समान नहीं है।

व्यक्ति की देखभाल

गंभीर बीमारी में आवश्यक स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षा का महत्त्व बना रहता है। अलग पद्धतियों की औषधियों का अनियोजित उपयोग उचित नहीं है।

> संस्थागत मान्यता, उत्पाद की गुणवत्ता और किसी विशेष उपचार के वैज्ञानिक प्रमाण अलग प्रश्न हैं।

संस्था, कार्यक्रम और मंच का अंतर

Institutions, Programmes and Platforms

पहचान	प्रकार	मुख्य संबंध
MoHFW	मंत्रालय	नीति और प्रशासन
ICMR	शोध संस्था	जैव-चिकित्सीय प्रमाण
NCDC	तकनीकी संस्था	रोग निगरानी और नियंत्रण
IDSP	कार्यक्रम	रोग की समय पर पहचान तथा प्रतिक्रिया
IHIP	सूचना मंच	डिजिटल निगरानी और जानकारी
NHA	प्राधिकरण	संबंधित वित्तीय और डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था
NHM	मिशन	व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन

अंतर क्यों महत्त्वपूर्ण है?

एक संस्था किसी कार्यक्रम का नेतृत्व कर सकती है और कार्यक्रम में कई विभाग काम कर सकते हैं। सूचना मंच उस काम का उपकरण हो सकता है। इसलिए संबंधित होना, एक ही इकाई होना नहीं है।

उदाहरण

प्रकोप की जानकारी मंच पर दर्ज हो सकती है। उसका विश्लेषण निगरानी कार्यक्रम में होता है। नियंत्रण में स्वास्थ्य संस्था, जिला प्रशासन और अन्य सेवाएँ काम करती हैं।

> नाम का संक्षेप याद करने के साथ उसकी संस्थागत श्रेणी भी समझें।

संस्थागत सहयोग: एक उदाहरण

Institutional Cooperation: An Example

जल जनित प्रकोप की स्थिति

एक क्षेत्र में दस्त के मामले बढ़ते हैं। स्वास्थ्य केंद्र रोगियों की देखभाल करता है, जिला निगरानी व्यवस्था जानकारी जुटाती है और जलापूर्ति विभाग दूषण की संभावना जाँचता है।

जरूरत	संबंधित भूमिका
रोगी की देखभाल	स्वास्थ्य केंद्र और आवश्यक रेफरल
असामान्य मामले पहचानना	जिला तथा **IDSP** संबंधी निगरानी
तकनीकी जाँच	संबंधित प्रयोगशाला और आवश्यकता पर उच्चतर संस्था
पानी तथा स्वच्छता सुधार	जलापूर्ति और स्थानीय निकाय
परिवार तक संदेश	स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय

अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्थान

विशेष परिस्थितियों में तकनीकी या मानवीय सहयोग उपयोगी हो सकता है। लेकिन प्रत्येक स्थानीय मामले में **WHO** या **UNICEF** को प्रत्यक्ष उपचारकर्ता समझना उचित नहीं है।

मूल समाधान

रोगी की सहायता के साथ दूषण का कारण, सेवा की कमी और जानकारी का प्रवाह सुधारना आवश्यक है। केवल एक विभाग के प्रयास से हर समस्या नहीं सुधरती।

> सार्वजनिक स्वास्थ्य में अलग संस्थाओं का काम एक साझा परिणाम की ओर जुड़ता है।

समन्वय और परिणाम का मूल्यांकन

Coordination and Evaluation

कार्य से प्रभाव तक

स्तर	उदाहरण
संसाधन (**Input**)	प्रशिक्षित कार्यकर्ता, धन और उपकरण
क्रिया (**Activity**)	प्रशिक्षण या स्वास्थ्य अभियान
तत्काल निष्पादन (**Output**)	आयोजित सत्र तथा दी गई सेवाएँ
परिणाम (**Outcome**)	सेवा का उपयोग, व्यवहार या क्षमता में सुधार
व्यापक प्रभाव (**Impact**)	बीमारी, मृत्यु या असमानता में बदलाव

मात्रा और गुणवत्ता

अधिक केंद्र या अधिक सत्र होना उपयोगी है, लेकिन सही सेवा, समय पर आपूर्ति और जरूरत वाले समूह तक पहुँच भी देखें। केवल संख्या से पूरी गुणवत्ता का निष्कर्ष नहीं निकलता।

जानकारी की गुणवत्ता

सही परिभाषा, नियमित अभिलेख और समय पर रिपोर्ट संस्थागत निर्णय में सहायता करते हैं। आँकड़ा गलत हो तो योजना तथा परिणाम की व्याख्या प्रभावित हो सकती है।

जवाबदेही और सीख

कार्य की जिम्मेदारी तथा समीक्षा स्पष्ट रखें। समस्या मिलने पर प्रशिक्षण, संसाधन या प्रक्रिया में सुधार करें। निगरानी का उद्देश्य केवल दोष ढूँढ़ना नहीं, सेवा बेहतर करना भी है।

> संस्थाओं का मूल्यांकन उनके उद्देश्य, कार्य और वास्तविक स्वास्थ्य परिणाम के संबंध से किया जाता है।

प्रमुख संस्थाओं का कार्य-सार

Major Institutions: A Functional Summary

संस्था	पहचान का मुख्य बिंदु
WHO	वैश्विक स्वास्थ्य दिशा और तकनीकी सहयोग
UNICEF	बाल अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास
UNFPA	प्रजनन स्वास्थ्य और जनसंख्या संबंधी सहयोग
ICMR	जैव-चिकित्सीय शोध
ICMR-NIN	पोषण और आहार का शोध
NCDC	रोग निगरानी, प्रकोप और नियंत्रण
NIHFW	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में प्रशिक्षण
FSSAI	खाद्य सुरक्षा और मानक
CDSCO	औषधि की केंद्रीय नियामक व्यवस्था
NMC	चिकित्सा शिक्षा और संबंधित पेशेवर मानक
NHA	संबंधित स्वास्थ्य वित्त तथा डिजिटल मिशन
NHSRC	स्वास्थ्य प्रणाली का तकनीकी समर्थन

सार का उपयोग

यह तालिका प्रमुख भूमिका याद करने का साधन है। कई संस्थाओं के काम में सहयोग या ओवरलैप संभव है। उन्हें एक ही काम तक सीमित करने के बजाय उनकी मुख्य पहचान समझें।

> समान स्वास्थ्य उद्देश्य के बावजूद शोध, नियमन, सेवा और प्रशिक्षण अलग दायित्व हैं।

मुख्य अवधारणाएँ और पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

अध्याय के केंद्रीय संबंध

अवधारणा	सार
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था	नीति, सार्वजनिक सेवा और संस्थागत जिम्मेदारी
अंतरसरकारी सहयोग	देशों और UN तंत्र की संयुक्त स्वास्थ्य भूमिका
शोध और प्रमाण	निर्णय के लिए वैज्ञानिक जानकारी
नियमन	गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों की व्यवस्था
निगरानी	जानकारी से जोखिम पहचान तथा प्रतिक्रिया
सेवा वितरण	परिवार तथा समुदाय तक वास्तविक सुविधा
समन्वय	अलग कामों को साझा परिणाम से जोड़ना

आवश्यक अंतर

WHO और **UNICEF**, **ICMR** और **CDSCO**, **NIN** और **FSSAI**, **NHA** और **NHM**, तथा **NCDC**, **IDSP** और **IHIP** की पहचान अलग है। मंत्रालय, संस्था, कार्यक्रम, मंच और कार्यकर्ता एक ही संस्थागत स्तर नहीं हैं।

स्वास्थ्य की साझा जिम्मेदारी

सही नीति और प्रमाण, उपलब्ध संसाधन, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, सुरक्षित उत्पाद और समान पहुँच मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करते हैं। परिवार तथा समुदाय की सहभागिता संस्थागत कार्य को अधिक उपयोगी बनाती है।

> संगठन की सही पहचान उसके गठन, अधीनता, मुख्य कार्य और अन्य संस्थाओं से संबंध समझने पर आधारित है।